

CAPÍTULO 11.5

Cilindros en Sedimento Urinario

PERFIL EUNACOM 1.06.1.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Diferenciación IRA vs IRC — Rol de la Ecografía Renal

El Problema Clínico

El paciente llega con creatinina elevada **y no sabe desde cuándo**. La definición formal (< 3 meses = IRA / > 3 meses = IRC) no siempre es aplicable. La **ecografía renal** es el examen clave para diferenciarlas.

Interpretación de la Ecografía Renal

TABLA 11.5.1: RESULTADO ECOGRÁFICO VS INTERPRETACIÓN MÁS PROBABLE	
RESULTADO ECOGRÁFICO	INTERPRETACIÓN MÁS PROBABLE
Riñones de tamaño normal, aspecto conservado	IRA (proceso agudo, sin daño estructural crónico)
Riñones atróficos (pequeños) o con signos de nefropatía	IRC (daño crónico irreversible)
Riñones grandes + IRC	Causas especiales (ver abajo)

Causas de IRC con Riñones Grandes (confunden con IRA)

TABLA 11.5.2: CAUSA VS NOTA	
CAUSA	NOTA
Diabetes (nefropatía diabética)	Causa más frecuente de IRC en Chile
Riñón de Mieloma	Depósito de paraproteínas
Amiloidosis renal	Depósito de amiloide
Asociado a VIH, VHC, VHB	Infección crónica
Riñón Poliquístico	Riñones muy grandes + quistes → la ECO hace el diagnóstico de inmediato

¿Cuándo ahorrarse la Ecografía?

- Si la causa de IRA es **evidente y leve** (ej.: diarrea severa + creatinina 1.4 mg/dL):
 - Tratar la causa (hidratación).
 - Controlar creatinina.
 - Solo si **no revierte**: pedir ECO.
- > La ecografía NO es necesaria si la IRA prerrenal tiene causa clara y responde rápido al tratamiento.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente presenta fiebre, dolor lumbar y sedimento urinario con leucocituria y cilindros leucocitarios. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Cilindros en Sedimento Urinario. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Cilindros hemáticos/eritrocitarios: PATOGNOMÓNICOS de glomerulonefritis.
- Cilindros piocitarios/leucocitarios: orientan a pielonefritis aguda (infección urinaria alta).
- Cilindros céreos y granulosos: característicos de necrosis tubular aguda.
- Cilindros hialinos: los más frecuentes, son NORMALES (proteína de Tamm-Horsfall).
- Los cilindros permiten diferenciar el nivel y tipo de lesión renal en el sedimento urinario.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CILINDROS EN SEDIMENTO URINARIO)

PREGUNTA 1

Un paciente presenta fiebre, dolor lumbar y sedimento urinario con leucocituria y cilindros leucocitarios. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Cistitis aguda
- ☐ B) Pielonefritis aguda
- ☐ C) Glomerulonefritis aguda
- ☐ D) Necrosis tubular aguda
- ☐ E) Hallazgo normal sin significado patológico

PREGUNTA 2

¿Cuál de los siguientes tipos de cilindros urinarios es un hallazgo normal y no indica patología?

- ☐ A) Cilindros hemáticos
- ☐ B) Cilindros granulosos
- ☐ C) Cilindros hialinos
- ☐ D) Cilindros leucocitarios
- ☐ E) Cilindros céreos

PREGUNTA 3

Paciente con hematuria y sedimento urinario que muestra cilindros eritrocitarios. ¿Qué diagnóstico confirma este hallazgo?

- ☐ A) Litiasis renal
- ☐ B) Cáncer vesical
- ☐ C) Glomerulonefritis
- ☐ D) Infección urinaria baja
- ☐ E) Necrosis tubular aguda

RESUMEN: CILINDROS EN SEDIMENTO URINARIO

Esta clase breve revisa los tipos de cilindros que se pueden encontrar en el sedimento urinario y su significado diagnóstico. Los cilindros hemáticos o eritrocitarios son patognomónicos de glomerulonefritis. Los cilindros piocitarios o leucocitarios orientan a pielonefritis aguda. Los cilindros céreos y granulosos son característicos de la necrosis tubular aguda. Finalmente, los cilindros hialinos son los más frecuentes, formados por acumulación de proteína de Tamm-Horsfall, y son completamente normales. Conocer estos tipos de cilindros es fundamental para el diagnóstico diferencial de las patologías renales a través del sedimento urinario.